

Aneurisma de Aorta Abdominal

Introducción y Etiología

El **Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA)** se define como una dilatación focal de la arteria aorta que alcanza un diámetro **mayor a 3 centímetros**. Es fundamental no confundir esta patología con la **Discción Aórtica**, ya que presentan fisiopatologías, clínicas y manejos radicalmente distintos.

La causa principal del AAA es la **enfermedad ateromatosa**. Debido a esto, el AAA se considera una manifestación de daño vascular sistémico.

NOTA CLÍNICA

- Fisiopatología:** La aterosclerosis produce una degradación de la túnica media de la pared arterial, debilitando las fibras de elastina y colágeno. Por la **Ley de Laplace**, a medida que el radio del vaso aumenta, la tensión de la pared también lo hace, incrementando exponencialmente el riesgo de rotura a partir de ciertos diámetros.
- Los pacientes con AAA comparten los mismos factores de riesgo que aquellos con **Síndrome Coronario Agudo** o **Hipertensión arterial esencial**:
 - Tabaquismo (el factor de riesgo modificable más potente).
 - Edad avanzada.
 - Sexo masculino.
 - Antecedentes familiares.
 - Dislipidemia y **Diabetes mellitus tipo 2**.

EUNACOM CRITERIOS

La causa más frecuente de muerte a mediano y largo plazo en pacientes con un AAA diagnosticado (no roto) no es la rotura del aneurisma, sino el **Infarto Agudo al Miocardio**. Por ello, el manejo integral de los factores de riesgo cardiovascular es obligatorio.

Presentación Clínica

El manejo y pronóstico dependen críticamente de si el aneurisma se encuentra estable (no roto) o si ha presentado una rotura.

1. AAA No Roto (Estable)

La inmensa mayoría de los casos son **absolutamente asintomáticos**. Suelen ser hallazgos incidentales en exámenes de imagen solicitados por otros motivos. - **Examen físico:** En algunos pacientes se puede palpar una **masa abdominal pulsátil**, habitualmente en el epigastrio o región periumbilical.

2. AAA Roto (Urgencia Vital)

Es una catástrofe vascular con una mortalidad extremadamente alta (cercana al 80-90% incluyendo muertes pre-hospitalarias). Se presenta con la tríada clásica: 1. **Dolor abdominal o lumbar intenso:** A menudo súbito. 2. **Hipotensión / Shock hipovolémico:** Taquicardia, palidez, compromiso de conciencia. 3. **Masa pulsátil palpable:** Presente en aproximadamente el 50% de los casos rotos.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Al AAA roto se le conoce como el **"embarazo ectópico del adulto mayor"** o el **"cólico renal severo del adulto mayor"**. Si un paciente añoso con factores de riesgo cardiovascular consulta por dolor lumbar súbito y signos de shock, sospeche AAA roto antes que un cálculo renal.

Diagnóstico

Para confirmar el diagnóstico y medir el diámetro (que es el parámetro que guía la conducta), se requieren imágenes:

TABLA 1.40.1: EXAMEN VS UTILIDAD

EXAMEN	UTILIDAD
Ecografía Abdominal	Excelente para screening (tamizaje) y seguimiento de aneurismas pequeños. Es barata, no irradia y tiene alta sensibilidad para medir el diámetro.
Angio-TAC de Abdomen y Pelvis	Es el estándar de oro para la planificación quirúrgica. Permite ver la anatomía precisa, la relación con las arterias renales y signos de rotura o hematoma retroperitoneal.

Cualquiera de los dos que muestre un diámetro **> 3 cm** confirma la presencia de un aneurisma.

Manejo del AAA No Roto

La decisión de intervenir quirúrgicamente se basa en el riesgo de rotura frente al riesgo de la cirugía. El punto de corte universal es el diámetro de **5,5 cm**.

Algoritmo según diámetro:

1. **Menor a 5,5 cm (Aneurisma pequeño):** - **Conducta:** Seguimiento periódico con ecografía. - **Frecuencia:** Cada 6 a 12 meses (dependiendo de qué tan cerca esté del límite). - **Tratamiento médico:** Control estricto de la presión arterial, uso de estatinas, aspirina y, fundamentalmente, **cese del hábito tabáquico**. 2. **Mayor o igual a 5,5 cm (o crecimiento rápido > 0,5 cm en 6 meses):** - **Conducta:** Cirugía programada (electiva). - **Técnicas:** - **EVAR (Reparación endovascular):** Colocación de un stent por vía femoral. Es la técnica de elección actual en muchos casos por su menor invasividad. - **Cirugía abierta:** Reemplazo de la aorta con un injerto sintético (Dacrón). 3. **Diámetros críticos (> 7-8 cm):** - Requieren cirugía a la brevedad posible, dado que el riesgo de rotura inminente es altísimo.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si el paciente presenta dolor abdominal persistente o sensibilidad a la palpación sobre un aneurisma conocido, se considera un **aneurisma sintomático** (pre-ruptura) y debe ser operado de urgencia, independientemente de su tamaño.

Manejo del AAA Roto

Es una emergencia quirúrgica. Muchos pacientes fallecen antes de llegar al hospital.

- Estabilización inicial:** Soporte hemodinámico con fluidos (suero fisiológico) y hemoderivados (transfusión de sangre) según protocolo de hemorragia masiva.
- Confirmación diagnóstica:** Si el paciente está inestable pero responde mínimamente a volumen, se puede realizar una **Ecografía FAST** o una **TAC de urgencia**. Si la sospecha es muy alta y el paciente está en shock profundo, puede ir directo a pabellón.
- Cirugía de urgencia:** Es la única medida definitiva para salvar la vida. Consiste en el clampeo aórtico y reparación del defecto.

TABLA 1.40.2: CARACTERÍSTICA VS AAA NO ROTO		
CARACTERÍSTICA	AAA NO ROTO	AAA ROTO
Clínica	Asintomático / Masa pulsátil	Dolor súbito + Shock + Masa
Diagnóstico	Eco o TAC (hallazgo)	TAC de urgencia / Eco FAST
Prioridad	Electiva (si > 5,5 cm)	Emergencia inmediata
Mortalidad	Baja en cirugía programada	Muy alta (> 50% operados)

Resumen de Perlas para el EUNACOM

PERLA CLÍNICA EUNACOM

- **Punto de corte para cirugía:** 5,5 cm en hombres (en mujeres a veces se considera 5,0 cm, pero 5,5 es el estándar para el examen).
- **Seguimiento:** Se prefiere la **Ecografía** para evitar la radiación repetida de la TAC. - **Principal causa de muerte:** Infarto al miocardio (en el seguimiento a largo plazo). - **Diagnóstico diferencial clave:** El cólico renal en el adulto mayor siempre debe hacerte descartar un AAA roto si hay inestabilidad hemodinámica. - **Manejo médico:** No solo es operar; el control de factores de riesgo (especialmente tabaco) es vital para prevenir la expansión y complicaciones cardiovasculares.

Recuerda que ante un paciente con un AAA detectado en atención primaria, tu rol es iniciar el manejo de factores de riesgo y derivar al cirujano vascular para el seguimiento especializado y la planificación de la eventual cirugía.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 72 años fumador con masa pulsátil epigástrica. Eco-FAST confirma aorta 5.8 cm."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Aneurisma Aorta Abdominal. Indicación quirúrgica si ≥ 5.5 cm en hombres o sintomático.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El AAA es una dilatación > 3 cm, más del 90% son infrarrenales
- El tabaquismo es el factor de riesgo más importante
- La mayoría son asintomáticos; screening con eco en hombres 65-75 años fumadores
- AAA roto: dolor abdominal/lumbar + hipotensión + masa pulsátil (mortalidad 80-90%)
- Reparación indicada con diámetro $\geq 5,5$ cm, crecimiento > 0,5 cm/6 meses o sintomático
- EVAR tiene menor mortalidad perioperatoria; cirugía abierta es más duradera
- El angio-TAC es el gold standard para planificación quirúrgica

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL)

PREGUNTA 1

Hombre de 70 años, fumador, se detecta incidentalmente un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal de 4,5 cm. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A) Reparación endovascular inmediata
- B) Vigilancia ecográfica cada 12 meses y control de factores de riesgo
- C) Cirugía abierta de emergencia
- D) Resonancia magnética mensual
- E) No requiere seguimiento porque es menor de 5 cm

PREGUNTA 2

¿Cuál es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de aneurisma de aorta abdominal?

- A) Diabetes mellitus
- B) Tabaquismo
- C) Obesidad
- D) Sedentarismo
- E) Consumo de alcohol

PREGUNTA 3

Paciente de 68 años consulta por dolor abdominal súbito irradiado a espalda, PA 80/50, FC 120 y masa abdominal pulsátil. ¿Cuál es la conducta?

- A) Ecografía abdominal y luego decidir
- B) TAC de abdomen con contraste
- C) Cirugía de emergencia
- D) Reanimación con volumen y observar evolución
- E) Angiografía diagnóstica

RESUMEN: ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL

El aneurisma de aorta abdominal (AAA) es una dilatación permanente de la aorta abdominal mayor a 3 cm o 1,5 veces el diámetro normal. La localización más frecuente es infrarrenal. Los factores de riesgo principales son tabaquismo (el más importante), edad mayor de 65 años, sexo masculino, HTA, dislipidemia y antecedentes familiares. El diagnóstico frecuentemente es incidental por ecografía o TAC solicitados por otro motivo. El screening con ecografía abdominal se recomienda una vez en hombres de 65 a 75 años fumadores o ex-fumadores. La mayoría son asintomáticos. El aneurisma roto se presenta con la tríada clásica de dolor abdominal o lumbar, hipotensión y masa abdominal pulsátil, y tiene alta mortalidad. El tratamiento del AAA no roto depende del tamaño. Aneurismas menores de 5,5 cm se manejan con vigilancia ecográfica periódica y control de factores de riesgo. La reparación se indica cuando el diámetro alcanza 5,5 cm (o 5 cm en mujeres), cuando crece más de 0,5 cm en 6 meses, o cuando es sintomático. Las opciones son reparación endovascular (EVAR) o cirugía abierta. El AAA roto requiere cirugía de emergencia.